

Leczenie *Gaming Disorder*

CBT skuteczne ($d=0,57-0,91$). Cel: kontrolowane granie, nie zerowa abstynencja. Plan oparty na czterech filarach: wyzwacze, dialog motywujący, alternatywne nagrody, rodzina.

CZAS: 25 min + budowa planu Protokół wieloelementowy

ŹRÓDŁO: Stevens (2021); King (2017); Young (2007)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrób pracę ambiwalencji w stylu dialogu motywującego (sekcja 01) — bilans zysków i strat. **2** · Zbuduj plan zdrowego grania (sekcja 02) — pięć konkretnych ograniczeń. **3** · Znajdź alternatywne źródła nagrody, dające tę samą funkcję, jaką pełni gra (sekcja 03). **4** · Jeśli mieszkasz z bliskimi — uzgodnij z nimi rolę i zasady (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Stevens i wsp. (2021, metaanaliza, $k = 30$ badań) wykazali, że *terapia poznawczo-behawioralna* dla zaburzenia gamingowego osiąga wielkość efektu $d = 0,57$ — efekt umiarkowany do dużego. King i wsp. (2017) w wcześniejszej metaanalizie raportowali $d = 0,91$ dla CBT-IA (CBT dla uzależnienia od internetu/gier). **Kluczowa różnica** wobec leczenia uzależnień od substancji: **pełna abstynencja jest niepraktyczna** — gry, ekrany i internet są częścią szkoły, pracy i komunikacji w XXI wieku. Cel terapeutyczny to *kontrolowane granie*, nie zerowa abstynencja (chyba że bardzo ciężkie nasilenie). Protokół opiera się na czterech elementach: **dialog motywujący** (większość pacjentów *nie chce* przestać grać — Hayes 2019), **CBT** (identyfikacja wyzwaczy, restrukturyzacja przekonań, plan zdrowego grania), **aktywacja alternatywnych nagród** (Community Reinforcement Approach, Meyers 2004), **terapia rodzinna** (zwłaszcza u nastolatków — Stevens 2019). Farmakoterapia jest *eksperymentalna*: bupropion redukuje craving w niewielkim stopniu (Han 2010), brak żadnego leku zatwierdzonego przez FDA.

01 ✎ Dialog motywujący — bilans zysków i strat

Większość osób z zaburzeniem gamingowym *nie chce* przestać grać — i to **w porządku**. Zamiast walczyć z oporem, zbuduj rozbieżność między tym, co Ci gra *daje*, a tym, co Ci *zabiera*.

CO GRY MI DAJĄ?

— co bym stracił/-a, gdybym przestał/-a

CO GRY MI ZABIERAJĄ?

— sen, oceny, pieniądze, relacje, zdrowie

Pytanie różdkowe: Gdybyś miał/-a magiczną różdkę i mógł/-a grać *bez* negatywnych konsekwencji — jak wyglądałby **idealny tydzień**? Ile godzin? W co? O jakich porach? Co byś jeszcze robił/-a w tym tygodniu?

02 ☉ Sześć zasad zdrowego grania

1 • MAKSYMALNY CZAS

Np. 2h/dzień w dni szkolne, 3h/dzień w weekendy. *Z góry ustalone*, alarm/timer wymusza koniec.

2 • PO OBOWIĄZKACH

Najpierw szkoła/praca, sport, posiłek, higiena — *dopiero potem* gra. Sekwencja stała.

3 • NIE PO 22:00

Granie w nocy rujnuje sen i rytm dobowy. Twardy koniec o 22:00 (lub 21:00 u młodzieży).

4 • NIE W „ALKOHOL”

Identyfikuj *swojego „alkoholu”* — gra, która zżera Cię najbardziej. **Tej nie gramy.** Inne — tak.

5 • DZIEŃ BEZ GIER

Minimum jeden pełny dzień w tygodniu *bez ekranu rozrywkowego*. Niedziela / sobota — rytuał rodzinny.

6 • APLIKACJE WYMUSZAJĄCE

Cold Turkey, Freedom, Screen Time — twarde blokady. Hasło u zaufanej osoby (nie u Ciebie).

03 💡 Alternatywne źródła tej samej nagrody

Gra daje konkretne nagrody — i właśnie *te* trzeba zastąpić, nie tylko „znaleźć coś innego”. Sprawdź, którą funkcję pełni Twoja gra, i wybierz **aktywność dającą tę samą**.

OSIĄGNIĘCIA + PROGRES

Wspinaczka (zbieranie tras), sport drużynowy (ranking, trening), nauka instrumentu (poziomy techniczne), bieganie (dystans/czas).

KONTAKT SPOŁECZNY

Klub sportowy, harcerstwo, wolontariat, zespół muzyczny, grupa rolowych gier *stacjonarnych*, kółko zainteresowań w szkole.

FLOW + SKUPIENIE

Rękodzieło, modelarstwo, gotowanie, programowanie projektu własnego, rysunek, fotografia. Każda aktywność wymagająca pełnej uwagi.

UCIECZKA / REGULACJA STRESU

Spacer/bieg w naturze, joga, kąpiel, czytanie, drzemka. *Świadoma* regulacja stresu — nie ucieczka, ale reset.

04 📋 Rola bliskich — co mogą, a czego nie

CO BLISCY MOGĄ

Wspólnie negocjować zasady (a nie narzucać). Trzymać hasło aplikacji blokującej. Spędzać czas *razem* w aktywnościach alternatywnych. Walidować trudne emocje przy odstawieniu („wiem, że trudno”). Chwalić utrzymanie zasad.

CZEGO BLISCY NIE POWINNI

Konfiskować sprzętu z dnia na dzień (eskalacja konfliktu). Moralizować („marnowanie czasu”). Spłacać długów za mikrotransakcje (*enabling*). Kontrolować *każdej minuty* (skutek: ukrywanie). Mówić „ty jesteś uzależniony” — etykietowanie obniża motywację.

Klucz: dla większości osób z zaburzeniem gamingowym cel terapii to *kontrolowane granie*, nie zerowa abstynencja. Wyjątek: bardzo ciężkie nasilenie z wielokrotnymi nieudanymi próbami kontroli — wtedy okresowa pełna pauza (np. 90 dni) *jest* uzasadniona. Konsekwencja kliniczna: **nie walcz z grami** jak z heroiną — buduj *alternatywne źródła* tej samej nagrody, którą gra dostarcza. Stevens i wsp. (2021): pacjenci, u których terapia obejmowała *aktywną budowę alternatyw*, mieli 2× lepsze utrzymanie zmiany po 12 miesiącach niż ci, u których protokół skupiał się wyłącznie na ograniczeniu.